Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Judicial da Comarca de Venâncio Aires

Rua Berlim da Cruz, 1306 - Bairro: Centro - CEP: 95800000 - Fone: (51) 3098-5597 - Email: frvaires3vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004728-68.2021.8.21.0077/RS

AUTOR: ANA PAULA NEDWED

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

ANA PAULA NEDWED ajuizou "Ação de Obrigação de Fazer" em face de **IPÊ-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**. Relatou que foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Fibromialgia (CID 10 F32.2 + F41 + M79). Disse que o grau da doença é crônico, de forma que muitas habilidades estão sendo comprometidas. Destacou que uso de fármacos convencionais não ocasionaram resposta favorável, sendo que a melhora no quadro clínico ocorreu somente com o uso de *óleo de cannabis* (Oil CBD Usa Hemp 6000mg), o qual foi indicado sob prescrição médica. Salientou que lhe foi receitado o uso de 01 frasco do óleo por mês. Aduziu, no entanto, que cada frasco curta R$ 1.343,16, não possuindo recursos para adquirir. Alegou que tentou recorreu ao plano de saúde, mas o réu negou o fornecimento. Frisou que, embora o medicamento à base de Canabidiol não possua registro na ANVISA, tem-se que a referida agência já autorizou a importação do medicamento para o tratamento. Ainda, disse que a Resolução RDC 17/2015 e RDC 66/2016, evidencia que a Autarquia reconhece a eficácia do medicamento, o que significa que inexiste risco para a saúde pública. Alegou a obrigação do plano de saúde em fornecer o medicamento. Salientou a ocorrência de danos morais, diante da negativa administrativa do réu. Requereu, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento pelo réu, sob pena de multa. No mérito, postulou pela procedência dos pedidos com a concessão definitiva da liminar, além de o réu ser condenado ao pagamento pelos danos morais ocasionados no montante de R$ 10.000,00. Pediu AJG. Juntou documentos (Evento 01).

Deferida a gratuidade judiciária, todavia, indeferida a tutela de urgência (Evento 03).

Formulado pedido de reconsideração (Evento 08), o juízo manteve o indeferimento da tutela de urgência (Evento 11).

Citada, a parte ré apresentou **CONTESTAÇÃO** (Evento 10). Referiu que o Ipê-Saúde, diferentemente dos planos de saúde privados, é instituído por Lei e administrado por uma Autarquia Estadual, sendo que qualquer medicamento a ser disponibilizado pelo IPE Saúde carece de previsão normativa inequívoca. Disse que a própria legislação exclui a concessão de todos os tratamentos que não estiverem previstos em normativas institucionais. Aduziu que não possui atenção farmacológica como existe no âmbito do Sistema Único de SUS – SUS, eis que não se rege pelos princípios da universalidade ou integralidade. Ressaltou que o fornecimento de fármacos pela cobertura do IPE Saúde está restrito aos atendimentos hospitalares ou ambulatoriais e, de forma, excepcional, aos tratamentos oncológicos. Outrossim, alegou inexistência de danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos (Evento 10).

Interposto Agravo de Instrumento (Evento 17), a 2ª Câmara Cível não conheceu o recurso (Evento 19).

O réu acostou aos autos informações prestadas pelo órgão técnico do Ipê-Saúde (Evento 20).

A parte autora apresentou manifestação (Evento 26).

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção (Evento 29).

As partes requereram o julgamento antecipado do feito (Eventos 38 e 44).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

É caso de julgamento antecipado da lide uma vez que a matéria em discussão é exclusivamente de direito e os documentos juntados são suficientes para a solução da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora postula a cobertura pelo Ipê-Saúde do fornecimento do medicamento Oil CBD Usa Hemp 6000mg *(óleo de cannabis)* a fim de tratar as doenças acometidas pela autora, quais sejam, Transtorno Depressivo Maior, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Fibromialgia (CID 10 F32.2 + F41 + M79).

No caso em comento, restou incontroverso que a autora apresenta Transtorno Depressivo Maior, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Fibromialgia (CID 10 F32.2 + F41 + M79), conforme atestado pelos laudos médicos acostados ao feito no Evento 01.

Ademais, conforme aponta os laudos médicos, em especial o da psiquiatra Dra. FELIANNE MEIRELLY ALVES DE MOURA - CRM 22323 DF, a autora já fez uso de outros medicamentos a fim de tratar os sintomas depressivos não obtendo êxito, sendo que a melhora dos sintomas ocorreu somente com o uso de óleo de cannabis ricos em CBD (usa hemp 6000mg). Vejamos o laudo médico (Evento 01 - Laudo16):

> *"Relatório Médico:*
>
> *Paciente encontra-se em tratamento psiquiátrico em regime de consultas , sob diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Fibromialgia, Cid 10 F32.2 + F41 + M79. Paciente apresenta sintomas depressivos de longa data, não respondendo ao uso de fármacos convencionais, já fez uso de todas as classes de antidepressivos sem sucesso, apresentava pensamentos de morte constantes, inclusive já teve várias tentativas de autoextermínio, associados a sintomas de ansiedade e dor crônica que pioravam ainda mais os sintomas depressivos. Diante da não resposta aos fármacos convencionais, foi introduzido o uso de óleo de cannabis ricos em CBD (usa hemp 6000mg), com melhora substancial após introdução do mesmo, com melhora do humor, da ansiedade, insonia e disposição. Atualmente em uso de Usa Hemp 6000mg 1 ml 12/12h com amostras grátis. A paciente nao apresenta condições financeiras de custear seu tratamento, e o uso regular da medicação Usa Hemp 6000mg 1 ml 12/12h é imprescindível, não havendo outras medicações que o substitua, uma vez que já fez uso de todas as classes de antidepressivos anteriormente sem sucesso."*

Nesses termos, segundo o laudo médico, uso de óleo de cannabis ricos em CBD (usa hemp 6000mg) é imprescindível para a melhora do tratamento da autora, na medida em que já fez uso de todas as classes de antidepressivos anteriormente sem sucesso.

No entanto, contesta o réu que o plano de saúde (Ipê-Saúde) é regulado por Lei Complementar, devendo seguir as disposições próprias para a concessão de cobertura, sendo que, no caso da autora, não poderia haver a concessão porque o tratamento não consta na tabela do próprio instituto. Ademais, assevera o réu que o medicamento sequer está registrado pela Anvisa.

Conforme assentado pelo réu, o plano de saúde Ipê-Saúde, de fato, é instituído pela Lei Complementar n° 15.145/18 e administrado por uma Autarquia Estadual, a qual obedece os parâmetros expostos pela referida legislação para a concessão de coberturas.

O artigo 4ª da referida Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, dispõe que:

> *"Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*
>
> *§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*
>
> *§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.*
>
> *§ 3º Para aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade de cobertura prestada na área da saúde, mediante prévio estudo técnico e atuarial, o Instituto poderá instituir Planos Especiais, para disponibilizar outros serviços ou procedimentos, cuja participação é opcional, mediante prévia solicitação e mensalidade específica, na forma que dispuserem o regulamento e atos normativos expedidos pelo Instituto."*

Nesses termos, com base no parágrafo 1º, em tese, ficariam excluídos da cobertura do Ipê Saúde todos os tratamentos, exames, insumos, entre outros, que não estivessem previstos na tabela feita pelo próprio instituto.

Sendo assim, o medicamento pretendido pela autora, por não constar na tabela do instituto, não foi custeado pelo plano de saúde.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento quanto à impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado, afirmando que é abusiva a cláusula que exclui cobertura de medicamento necessário a assegurar o tratamento de doenças.

Segue os precedentes da Corte Superior:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.*
>
> *1. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.*
>
> *(...)*
>
> *(AgInt no AREsp 1353634/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)*
>
> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.* ***PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC****. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*
>
> *1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais.*

*2. **O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"** (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.*

(AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018) (Grifei)

No mesmo norte, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também firmou entendimento sob o prisma da Lei 15.145/2018 referente ao Ipê-Saúde:

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA. AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO, ESTÁGIO IV. MEDICAÇÃO. PEMBROLIZUMABE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. **DESCABE AO PLANO DE SAÚDE PÚBLICO SELECIONAR O TIPO DE MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DO SEGURADO**. A Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE), prevê a cobertura de atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento da patologia de que padece o beneficiário." **Em que pese a edição da Lei Complementar nº. 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº. 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão no Protocolo Oncológico 2010 e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurada da autarquia**. [...] APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 70084227479, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 30-07-2020) (Grifei)*

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IPERGS. IPÊ-SAÚDE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIBOCICLIBE (KISQUALI®). TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO IPÊ-SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADOR PARTICULAR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. MINORAÇÃO. CABIMENTO. 1. Uma vez comprovada a cisão do IPERGS em IPÊ-SAÚDE e IPÊ-PREVIDÊNCIA, impõe-se a retificação do polo passivo da presente demanda. 2. **Em que pesem as disposições da Lei Complementar nº 15.145/18, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Inclusive, válido ressaltar que, de acordo com as Recomendações em Oncologia do próprio Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, atualizadas em dezembro de 2018 – elaboradas pelo Comitê Científico de Oncologia e Hematologia da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul – as orientações ali constantes não têm pretensão de ser completas ou definitivas, restando destacado, ainda, que "não tem como objetivo interferir na conduta médica ou autonomia profissional" e que "casos excepcionais e não previstos neste momento poderão ser encaminhados para discussão", sendo que estes medicamentos "serão revisados continuamente".** 3. Assim, considerando que as Recomendações não apresentam caráter definitivo ou excludente – e, ao revés, preveem expressamente a possibilidade de exame de casos excepcionais, bem como a não intervenção na autonomia do médico assistente –, desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico oncológico cujos protocolos adotados não se pretendem definitivos e se encontram, em contínua revisão, mormente quando a perícia médica judicial é favorável à pretensão da demandante. 4. **Ainda que assim não fosse, ao Plano de Saúde não cabe selecionar o tipo de tratamento que será coberto. Ou seja, assim como ocorre nos Planos de Saúde de natureza privada, se há previsão contratual de cobertura da patologia, não cabe ao Plano de Saúde ou ao Poder Judiciário selecionar o tipo de tratamento que terá ou não cobertura**. Exegese do art. 422 do Código Civil, pois naquilo em que o Plano de Saúde oferece cobertura (no caso, oncologia), entende-se que ela deve ser a mais ampla possível. Precedentes do STJ e deste TJRS. 5. Considerando o valor inestimável do direito à saúde, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada por apreciação equitativa do julgador, por força do §8º do art. 85 do CPC/2015 e em observância aos vetores do §2º do mesmo artigo, notadamente porquanto o condenado é a Fazenda Pública. 6. Minoração do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, tendo em vista os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos e em conformidade com os critérios do §2º do art.85 do CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70084342450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 29-07-2020) (Grifei)*

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. DEVER DE FORNECIMENTO DO IPÊ-SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO DE FONOTERAPIA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO. QUESTÃO ATINENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO TRATAMENTO JÁ REALIZADO NÃO CONHECIDA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. No caso vertente, há nos autos prescrição médica que valida o fornecimento dos tratamentos de fisioterapia, hidroterapia e equoterapia, sob pena de aumentar o risco de progressão de doença e consequente piora da qualidade de vida do autor. 2. **Em que pese o §1º do art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 exclua expressamente da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais que não estejam previstos nas tabelas próprias do instituto, no caso em concreto não é possível a limitação de tratamento pelo plano de saúde**. A cobertura se dá em razão da patologia, não podendo haver restrição quanto ao tratamento, cuja responsabilidade é do médico que acompanha o autor. 3. Desse modo, tem o agravante, na condição de segurado do agravado, o direito de recebê-los, visto que à referida autarquia compete propiciar aos seus beneficiários os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento de seus segurados. Em reforço, destaca-se que a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, o que, no caso dos autos, deve ser concretizado por meio do IPE-SAÚDE. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70083761023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 02-07-2020) (Grifei)*

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-SAÚDE. CONVENIADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). APLICABILIDADE DA LEI Nº 15.145/18. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. **- O art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, dispõe que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto (§1º). Ocorre que o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJRS é claro no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado.** APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PERIÓDICO. DESNECESSIDADE. - Desnecessária a determinação de apresentação de laudo médico periódico para a liberação do fármaco ao conveniado, tendo em vista que o tratamento está limitado ao período de 12 meses, devendo ocorrer reavaliação posterior. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA DE FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. - Aplicação do disposto no art. 85, §8º, do CPC ao caso em tela em observância à determinação*

legal do STJ em ação análoga. Fixação por apreciação equitativa. [...] APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70084060565, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 04-06-2020) (Grifei)

Com efeito, embora o art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, disponha que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto (§1º), o entendimento jurisprudencial do STJ e do TJRS é claro no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado.

Assim, não prospera a alegação quanto a impossibilidade de cobertura sob o argumento de que o tratamento não se encontra nas tabelas do próprio instituto.

Por outro lado, em observância ao REsp 1.657.156-RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 25/04/2018, referente ao Tema 106, em face da semelhança dos direitos em conflito, imperioso exigir-se, para medicamentos fora da lista dos fornecidos pelo IPE-SAÚDE, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da (a) imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pela autarquia, e a (b) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Na hipótese contida nos autos, os laudos comprovam a imprescindibilidade de uso do medicamento, considerando as prévias tentativas de uso de inúmeras medicações disponíveis no mercado, sem sucesso, conforme atestado pelos laudos juntados no Evento 01.

Todavia, não resta comprovado o registro do medicamento pretendido (Oil CBD Usa Hemp 6000mg) na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que inviabiliza a procedência do pedido.

O registro na ANVISA representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. Nesse contexto, necessário atentar para a tese fixada no julgamento do RE 657.718, Tema 500 do STF:

> *"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.*
>
> ***2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.***
>
> ***3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:***
> *(i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);*
> *(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e*
> ***(iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.***
>
> ***4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União*** *" (grifei)*

Assim, diante da inexistência de registro na ANVISA, inviável a procedência do pedido.

Outrossim, em relação ao pedido de danos morais, verifico que a situação ocorrida referente a negativa do réu em fornecer o medicamento não ultrapassou o mero dissabor.

Na esteira do ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho "*mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"*

A respeito do conceito de dano moral, também destacam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho que *"o dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente".*

Assim, no caso dos autos, não vislumbro a incidência de danos morais, visto que a negativa administrativa do plano de saúde quanto ao fornecimento dos medicamentos não é causa suficiente a gerar danos morais passíveis de reparação.

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. MEDICAMENTOS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALECIMENTO DO PACIENTE. SUCESSÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. - A negativa do fornecimento de medicamento pelo plano de assistência médica não configura danos morais indenizáveis. Não é qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar reparação por dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50143474820208210015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 20-10-2022)*

Logo, a medida que se impõe é a improcedência dos pedidos.

Ante ao exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** os pedidos formulados por **ANA PAULA NEDWED** em face de **IPÊ-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos procuradores dos requeridos, fixados em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o patrono do réu, devidamente atualizados, observados os critérios do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da AJG concedida.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA REGINA MOREIRA, Juíza de Direito**, em 25/5/2023, às 18:38:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10039002785v11** e o código CRC **3964bd26**.